

Le profil vitaminique chez les sujets obèses : a propos de 53 cas

N. Zerrouki ¹, M.Bougrida ^{1,2}

¹Service de Physiologie et des Explorations Fonctionnelles CHU Constantine (Algérie)

²Laboratoire de Recherche des Maladies Métaboliques (LR2M) Faculté de Médecine Université Constantine



Introduction

- Les déficits vitaminiques chez les obèses contribuent aux dysfonctionnements métaboliques. Ainsi, les déficits en vitamine D sont impliqués dans l'insulino-résistance et l'inflammation, et ceux en vitamines B9 et B12 dans les défauts de méthylation
- L'objectif de notre travail est d'évaluer le déficit des vitamines D; B12 et des folates chez des sujets présentant une obésité.

Moyens et Methodes

Étude rétrospective descriptive analytique réalisée au service de physiologie clinique et explorations fonctionnelles du CHU Constantine, allant de Janvier 2025 à Février 2026, incluant 53 patients ayant un IMC ≥ 30 kg/m², (obésité grade I: 30-34.9 Kg/m²; Grade II: 35-39.9; Grade III ≥ 40 kg/m²). On a procédé au recueil des données cliniques, para cliniques et démographiques sur une fiche d'exploitation

Résultats

Caractéristiques cliniques

	Age (ans)	IMC kg/m ²	TT
Moyenne	43	31,9	104,4
Ecart type	± 06	±5,4	± 2,5

Discussion

Dans une étude menée au Laboratoire de Biochimie CHU Tlemcen, Algérie, on a mis en évidence que les patients ayant une obésité morbide présentent une carence en vitamine D, 69 % des patients obèses présentent une carence en vitamine D [1],

ces résultats sont équivalents avec d'autres études celle Robert . B. en 2001 et Wortsman, J. en 2000. 75% des patients obèses ont une carence en vitamine D (p=0,08) [2]
L'association inverse entre l'IMC et la 25 (OH) D était plus forte parmi d'autres études réalisés; p = 0,004 par Vimalaswaran, K. S [3]

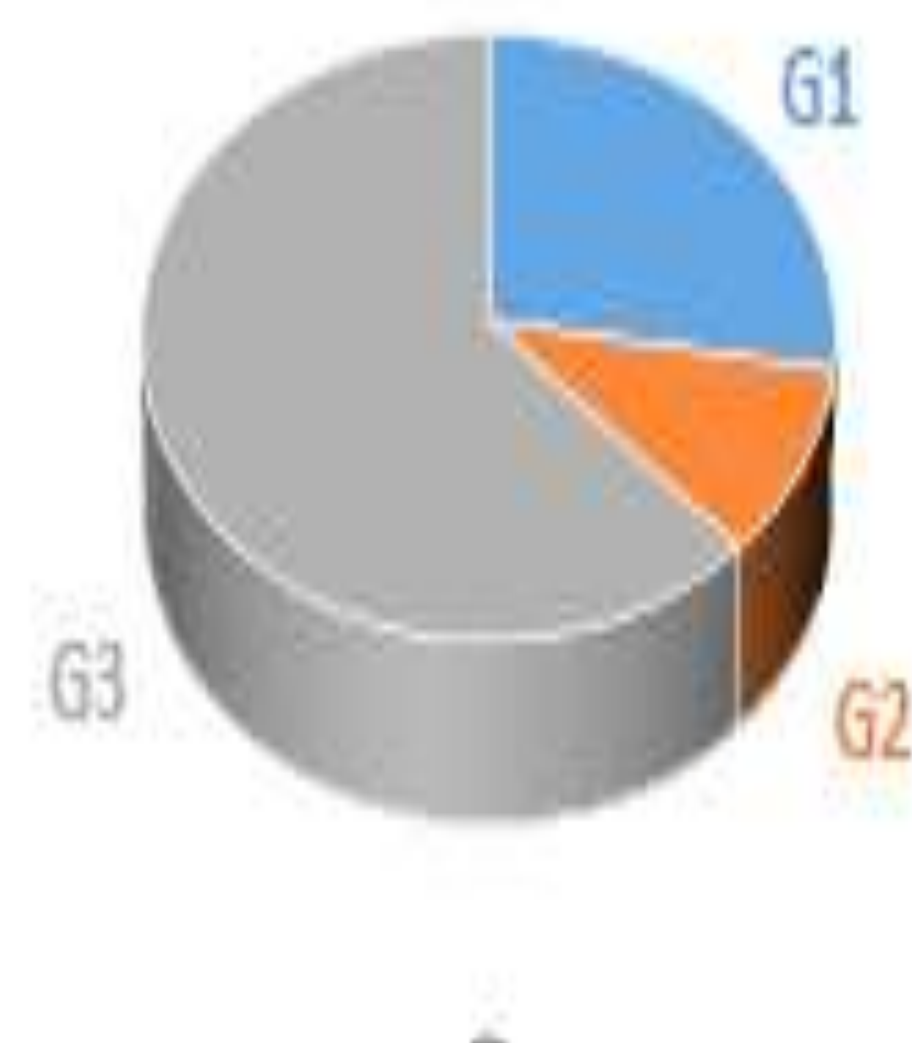


Figure 1 : Répartition de la population selon le grade de l'obésité

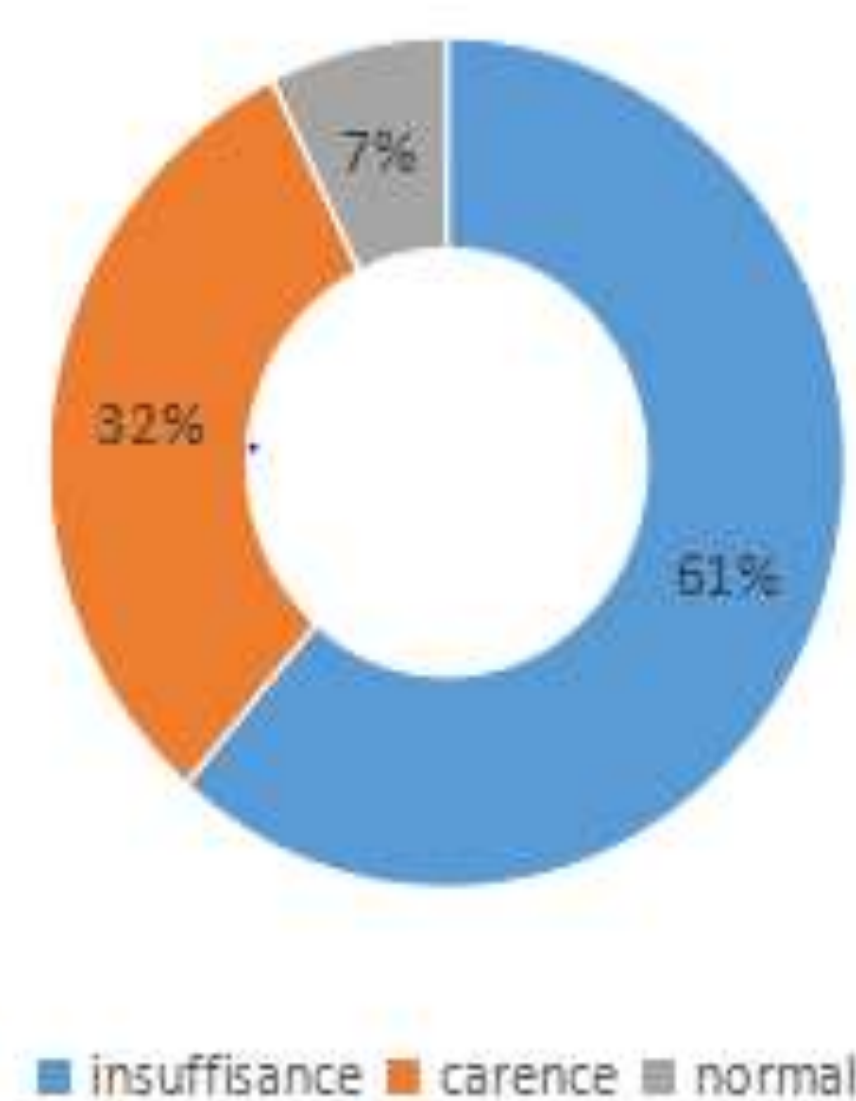


Figure 2: Répartition des malades selon le taux de la vitamine D

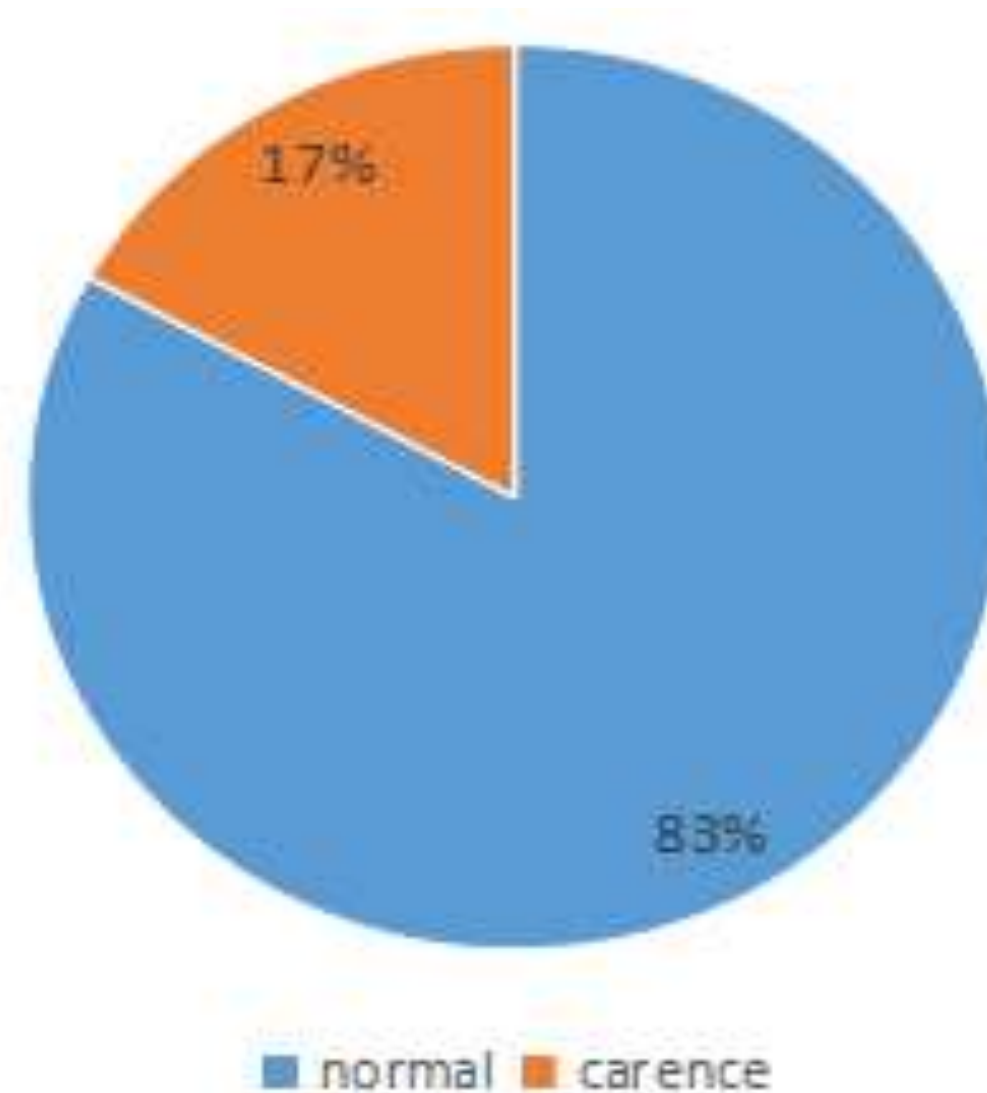


Figure 3: répartition des patients selon le statut en vit B12 et des folates

en 2013. Dans la population féminine de l'étude de Tlemcen 75% des femmes présentaient une carence en vitamine D, contre 13% des hommes dans la population masculine présente une carence en vitamine D, ce qui est comparable avec d'autres études de Vimalaswaran, K. S. en 2013.[4],

toutes ces résultats concordent avec les résultats trouvés dans nos études

Pour ce qui concerne les autres vitamines, une étude menée en Danemark au Clinical Nutrition Research Unit, une LED (Low energy diet) de huit semaines a entraîné une perte de poids de 13% et une augmentation des concentrations sériques en folate, vitamine B12 et vit D chez les sujets obèses et en surpoids. L'adiposité de base était inversement associée au folate et positivement associée aux marqueurs de l'inflammation.

Conclusion

les déficits en vitamine D sont impliqués dans l'insulino-résistance et l'inflammation, et ceux en vitamines B9 et B12 dans les défauts de méthylations. Ces déficits augmentent les risques de pathologies comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et inflammatoires ou les altérations neurologiques d'où la nécessité de dépistage systématique des déficits vitaminiques et leur prise en charge chez les sujets obèses,

Références

- [1].contribution a l'étude des interrelations entre le régime alimentaire et le statut.. DEPARTEMENT DE BIOLOGIE MOLECULAIRE ET CELLULAIRE. TLEMCEEN, UNIVERSITE ABOU BAKR BELKAID TLEMCEEN
- [2] Robert . B. en 2001 et Wortsman, J. en 2000
- [3] Vimalaswaran, K. S
- [4] Vimalaswaran, K. S. en 2013